

SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE PERNAMBUCO
CAT SERTÃO



**TEMA 13 • CRISE CONVULSIVA E
EMERGÊNCIAS NEUROLÓGICAS**

**Proteção da vítima, fases da crise tônico-clônica, o que NÃO fazer e
suporte seguro**

Instrutor: 1º TEN QOCBM GERALDO



GOVERNO DE
PER
NAM
BUCO
ESTADO DE MUDANÇA



JUNTOS PELA
SEGURANÇA
GOVERNO DE PERNAMBUCO

Quem conduz este módulo

INSTRUTOR

1º Tenente Geraldo

Oficial Bombeiro Militar

CBMPE

FORMAÇÃO

Engenharia Química

Universidade Federal de Pernambuco (UFPE)

ESPECIALIZAÇÃO

Pós-graduação em Atendimento Pré-Hospitalar (APH)

ATUAÇÃO

Especialista em APH e Resgate Operacional

O que o participante deve ser capaz de fazer ao final

- **Reconhecer** uma crise convulsiva e suas fases no ambiente pré-hospitalar e comunitário.
- **Proteger** a cabeça e o corpo da vítima, afastando objetos e riscos ao redor.
- **Evitar** condutas perigosas: nada na boca, não puxar a língua, não conter à força.
- **Cronometrar** a crise e posicionar em lateral de segurança no pós-ictal.
- **Socorristas:** estado de mal epilético, convulsão febril, trauma por queda e XABCDE.

REGRA DE OURO

Proteja, cronometre e observe.

A crise não se interrompe com força. O papel de quem socorre é impedir lesões e reconhecer quando ela se torna emergência.

CRISE CONVULSIVA × EPILEPSIA

Toda epilepsia causa crises, mas nem toda crise é epilepsia

CONCEITO

Crise convulsiva

- Descarga elétrica anormal e excessiva de neurônios no cérebro.
- Movimentos involuntários, rigidez, alteração ou perda de consciência.
- É um sintoma — pode ocorrer uma única vez, em qualquer pessoa.

CONCEITO

Epilepsia

- Doença neurológica crônica com crises recorrentes não provocadas.
- Cerca de 50 milhões de pessoas no mundo (OMS).
- Com tratamento adequado, até 70% ficam livres de crises (OMS).

Causas agudas que o socorrista deve lembrar

Hipoglicemia · TCE · febre (crianças) · AVC · intoxicação ou abstinência de álcool/drogas · hipóxia · eclâmpsia (gestante) · infecções do SNC · abandono do anticonvulsivante

FASES DA CRISE TÔNICO-CLÔNICA

SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE PERNAMBUCO
CAT SERTÃO

Reconhecer a fase orienta o que fazer em cada momento

ANTES

Aura / pródromo

- Sensação estranha, cheiro, visão ou mal-estar.
- Nem sempre ocorre.

FASE 1

Tônica

- Perda súbita de consciência e queda.
- Rigidez; apneia breve e cianose.

FASE 2

Clônica

- Abalos rítmicos, salivação, mordedura de língua.
- Geralmente 1 a 3 minutos.

DEPOIS

Pós-ictal

- Sonolência, confusão, respiração ruidosa.
- Recuperação em minutos a horas.

SOCORRISTA

Deite a vítima no chão, longe de quinas e escadas.

SOCORRISTA

Proteja a cabeça e marque o horário.

SOCORRISTA

Afastे objetos. Não contenha, nada na boca.

SOCORRISTA

Posição lateral de segurança e reavaliação.

O QUE FAZER DURANTE A CRISE

Sequência segura para público geral e socorristas

- 1** **Segurança da cena:** avalie riscos e use EPI antes de se aproximar.
- 2** **Marque o horário** de início da crise (relógio ou celular).
- 3** **Afastar objetos** e deixe espaço livre; só mova a vítima se houver perigo.
- 4** **Proteja a cabeça** com algo macio (casaco, mochila) ou com as mãos.
- 5** **Afrouxe roupas** apertadas no pescoço e retire óculos.
- 6** **Após os abalos**, posição lateral de segurança e observe a respiração.
- 7** **Fique ao lado** até recuperar a consciência; tranquilize e oriente.

Enquanto a crise ocorre

Sua função é proteger e observar. Na maioria dos casos, os movimentos cessam sozinhos.

Observe e relate à equipe

Duração, tipo de movimentos, lado do corpo, lesões e como foi a recuperação.

O QUE NUNCA FAZER

Mitos que causam lesões na vítima e em quem socorre

✗ NUNCA FAÇA

- Colocar a mão, colher, pano ou qualquer objeto na boca.
- Tentar puxar ou "desenrolar" a língua.
- Segurar ou conter os movimentos à força.
- Oferecer água, remédio ou alimento durante ou logo após a crise.
- Jogar água no rosto ou tentar "acordar" a vítima.
- Deixar a vítima sozinha.

✓ FAÇA NO LUGAR

- Proteger a cabeça e deixar a boca livre.
- A língua não é "engolida": lateralizar mantém a via aérea.
- Afastar objetos e deixar os movimentos acontecerem.
- Só dar algo pela boca com consciência plena e deglutição segura.
- Aguardar a recuperação espontânea, falando com calma.
- Permanecer junto e acionar ajuda quando indicado.

Por que isso importa?

Objetos na boca quebram dentes, obstruem a via aérea e ferem os dedos de quem socorre. Contenção à força provoca fraturas e luxações.

Cronometrar é uma intervenção, não um detalhe

LIMITE CRÍTICO

5

MINUTOS

Crise com duração igual ou maior que 5 minutos é emergência: acione o SAMU 192 imediatamente.

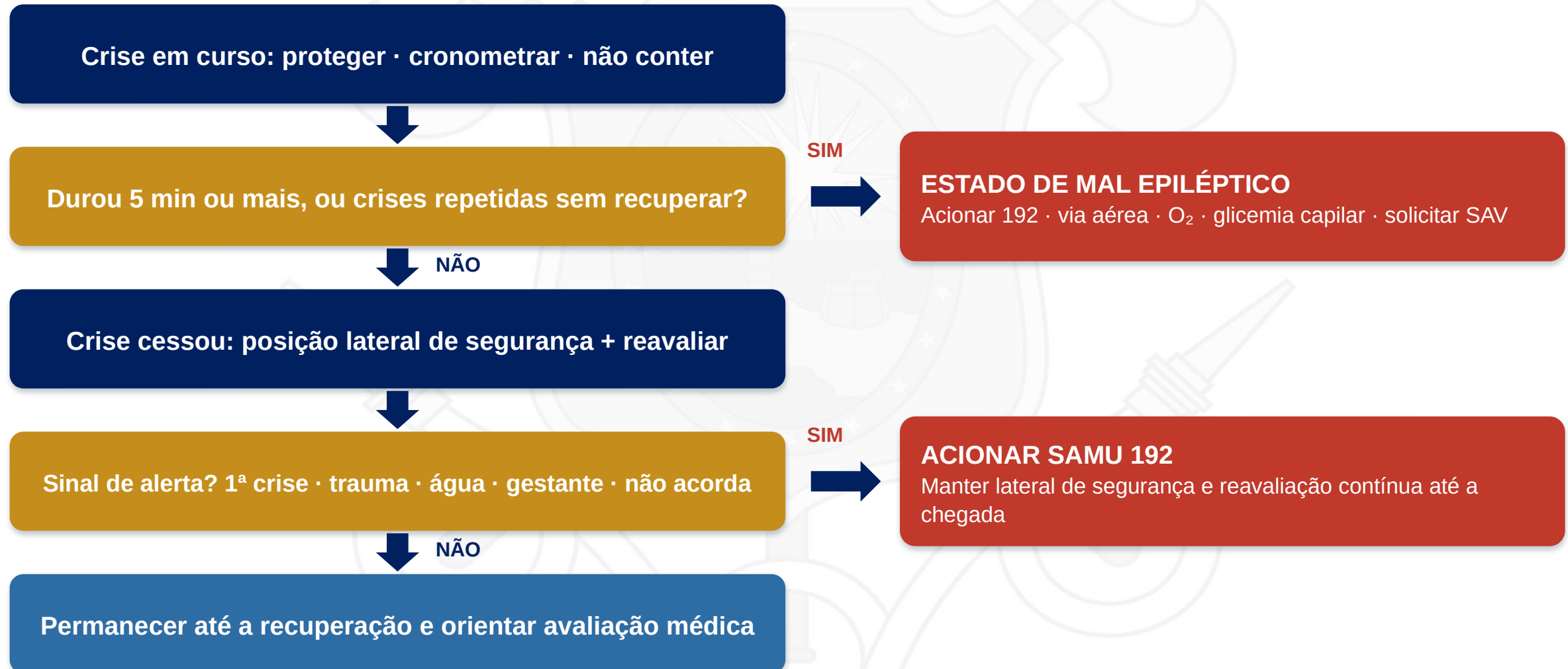
Acione o SAMU 192 também quando:

- É a primeira crise da vida ou não há histórico conhecido.
- Crises se repetem sem recuperação da consciência entre elas.
- A vítima não acorda ou respira com dificuldade após a crise.
- Houve lesão na queda ou a crise ocorreu na água.
- Gestante, diabético ou suspeita de intoxicação.
- A crise foi diferente do padrão habitual da pessoa.

FLUXO DE DECISÃO NA CRISE

SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE PERNAMBUCO
CAT SERTÃO

Do primeiro abalo ao acionamento: o tempo guia a conduta



Base normativa: AHA/Cruz Vermelha — 2024 First Aid Guidelines; SAMU 192; ILAE.

Status epilepticus: emergência neurológica tempo-dependente

Definição operacional (ILAE)

Crise contínua ≥ 5 minutos, ou duas ou mais crises sem recuperação da consciência entre elas. Após 30 minutos, alto risco de lesão neurológica permanente.

Prioridade no pré-hospitalar	Conduta
Cena e proteção	Proteger contra trauma; não conter; anotar horário de início
Via aérea	Lateralizar; aspirar secreções; cânula nasofaríngea se necessária (nunca forçar a boca)
Oxigenação	O ₂ suplementar; monitorar SpO ₂ e padrão ventilatório
Glicemia capilar	Aferir precocemente: hipoglicemia é causa tratável
Suporte avançado	Solicitar SAV/regulação médica: benzodiazepínico é conduta médica
Transporte	Monitorar sinais vitais; reavaliar continuamente; informar tempo total de crise

CONVULSÃO FEBRIL EM PEDIATRIA

SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE PERNAMBUCO
CAT SERTÃO

Assusta a família, mas na maioria das vezes é benigna

QUEM

Faixa etária

- 6 meses a 5 anos.
- Febre, geralmente $\geq 38^{\circ}\text{C}$.

TIPO

Simplex

- Generalizada, < 15 minutos.
- Não se repete em 24 horas.

TIPO

Complexa

- Focal ou ≥ 15 minutos.
- Ou repetida em 24 horas.

✗ NÃO FAÇA

- Banho frio, álcool ou compressas geladas durante a crise.
- Dar antitérmico ou líquidos pela boca durante a crise.
- Sacudir a criança ou colocar objetos na boca.

✓ FAÇA

- Proteja, lateralize, retire o excesso de roupas e cronometre.
- Tranquilize a família e acione o SAMU 192.
- Toda primeira convulsão febril deve ser avaliada por médico.

TRAUMA ASSOCIADO E XABCDE

A queda durante a crise pode gerar lesões graves

Letra	Aplicação na vítima pós-crise
X	Hemorragia exsanguinante por trauma na queda
A	Via aérea + restrição de movimento da coluna se trauma
B	Ventilação e SpO ₂ ; O ₂ suplementar se necessário
C	Pulso, perfusão e controle de sangramentos
D	AVDI/Glasgow, pupilas, glicemia capilar, déficit focal
E	Exposição: lesões, mordedura, hipotermia/hipertermia

⚠ Suspeita de trauma

Queda de altura, TCE ou crise na via pública: restrição de movimento da coluna e lateralização em bloco.

Pense na causa

Crise após trauma craniano pode indicar lesão intracraniana grave.

POSIÇÃO LATERAL DE SEGURANÇA

Pós-ictal: após os abalos, a prioridade é a via aérea

- 1 Ajoelhe-se ao lado da vítima, em decúbito dorsal.
- 2 Braço mais próximo em ângulo reto, palma para cima.
- 3 Outro braço sobre o tórax, dorso da mão junto à face.
- 4 Flexione o joelho do lado oposto e role a vítima para você.
- 5 Cabeça levemente estendida, boca voltada para baixo.
- 6 Reavalie a respiração até a chegada do socorro.

POR QUE LATERALIZAR?

Drena saliva e vômito

Reduz o risco de broncoaspiração.

Mantém a via aérea pérvia

A língua não obstrui com a cabeça lateralizada.

Em suspeita de trauma

Rolamento em bloco, protegendo a coluna.

Consensos internacionais e diretrizes nacionais que fundamentam o módulo

Fonte	Referência	Acesso
Ministério da Saúde — SAMU 192	Protocolos de SBV: emergências neurológicas e crise convulsiva	gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-a-a-z/s/samu-192
AHA / American Red Cross	2024 Guidelines for First Aid: Seizures and Recovery Position	cpr.heart.org/en/resuscitation-science/2024-first-aid-guidelines
OMS (WHO)	Fact sheet: Epilepsy	who.int/news-room/fact-sheets/detail/epilepsy
Liga Brasileira de Epilepsia	Primeiros socorros na crise convulsiva	epilepsia.org.br
PHTLS 10ª edição	Trauma e alterações neurológicas no suporte pré-hospitalar	Livro-texto (NAEMT)

SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE PERNAMBUCO
CAT SERTÃO



**TEMA 13 • CRISE CONVULSIVA E
EMERGÊNCIAS NEUROLÓGICAS**

**Proteção da vítima, fases da crise tônico-clônica, o que NÃO fazer e
suporte seguro**

Instrutor: 1º TEN QOCBM GERALDO



GOVERNO DE
PER
NAM
BU
CO
ESTADO DE MUDANÇA



JUNTOS PELA
SEGURANÇA
GOVERNO DE PERNAMBUCO